



Trastornos adaptativos. Duelo

C. Valcárcel Díaz*, L. Calderón Cos, R. Hermosillo Torres y P. Herrero Calvo

Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Trastorno adaptativo
- Duelo
- Pérdida
- Estrés

Keywords:

- Adjustment disorders
- Grief
- Loss
- Stress

Resumen

Los trastornos adaptativos constituyen un diagnóstico fronterizo que ofrece importantes dudas en cuanto al diagnóstico y abordaje por parte de los profesionales sanitarios. Mención aparte merece el duelo como fenómeno con reciente entidad diagnóstica, ya que, aun guardando relación con los trastornos adaptativos y pudiendo conceptualizar la pérdida como posible factor estresante, pueden darse complicaciones particulares en el proceso de elaboración que requieren un abordaje específico.

Abstract

Adjustment disorders. Grief

Adjustment disorders are a borderline diagnosis that raises important questions in regard to its diagnosis and approach by healthcare professionals. Grief merits special mention as a new diagnosis given that, even though it is related to adjustment disorders and loss can be understood as a possible stressor, it can entail particular complications that require a specific approach.

Introducción

Los trastornos de adaptación y el duelo podrían considerarse diagnósticos limítrofes entre lo normal y lo patológico. Ambas categorías aluden al factor etiológico como aspecto central en su definición, siendo este una situación estresante o de pérdida frente a la que la persona encuentra dificultades para adaptarse. En ese sentido, situaciones estresantes que conllevan cambios o pérdidas forman parte de la experiencia humana. Por tanto, podríamos hablar de ambas entidades como el resultado de dificultades en la adaptación a la «problemática de la vida cotidiana». Por otro lado, la sintomatología, en ocasiones imprecisa, se solapa con la presente en otros diagnósticos clínicos.

El objetivo que este trabajo plantea es contribuir a la actualización de conocimientos para la mejora y adquisición de competencias en la detección y manejo terapéutico del conjunto de síntomas que surgen en respuesta a la presencia de factores estresantes y/o pérdidas significativas.

Trastornos adaptativos

Definición y concepto

El trastorno adaptativo es uno de los diagnósticos más frecuentes, a pesar de tratarse de una categoría que carece de criterios diagnósticos propios. Nos encontramos ante una entidad cuyas manifestaciones se encuentran a caballo entre las consideradas «reacciones normales» ante diversos estresores y aquellos trastornos mentales que presentan una entidad diagnóstica por sí mismos. Por tanto, podrían considerarse como una categoría residual, ya que no pueden ser diagnosticados cuando se reúnen criterios para otro diagnóstico.

Al tratarse de una categoría fronteriza, el trastorno adaptativo presenta problemas taxonómicos y de diagnóstico, encontrándose pobremente definido y presentando problemas de fiabilidad y validez¹.

El trastorno adaptativo es un fenómeno relacionado con las dificultades en el afrontamiento del estrés, provocándose una desadaptación y unos síntomas que se mantienen hasta que se elimina el factor estresante o tiene lugar una nueva adaptación.

Podríamos definirlo como una reacción emocional o del comportamiento que aparece ante una situación estresante

*Correspondencia

Correo electrónico: carolina.valcarcel@salud.madrid.org

identificable, o que provoca un cambio en la vida de la persona, a la cual el individuo no es capaz de ajustarse adecuadamente, apareciendo respuestas emocionales y/o conductuales más intensas e incapacitantes de lo esperado.

Los trastornos agrupados en esta categoría aparecen siempre como respuesta directa a un estresor agudo o a una situación estresógena sostenida en el tiempo. El acontecimiento estresante es, por tanto, un factor primordial, de tal manera que en su ausencia no se hubiera producido el trastorno.

Si bien hay que aceptar que el trastorno no se hubiera presentado en ausencia del estresor, tomando un mismo factor estresante no hay manera de predecir qué persona terminará recibiendo un diagnóstico de trastorno adaptativo, aunque se considera que tanto la intensidad y duración del acontecimiento estresante como la predisposición o vulnerabilidad individual pueden influir en la aparición de la patología.

Criterios diagnósticos

Actualmente, los sistemas de clasificación más empleados son el DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) propuesto por la APA (*American Psychiatric Association*) y la CIE (Clasificación Internacional de las Enfermedades) propuesta por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

El término de trastorno adaptativo aparece por primera vez en DSM-III, siendo categorizado como una respuesta desadaptada a estresores cotidianos². En el DSM-5, los trastornos adaptativos se han incluido dentro de los trastornos relacionados con el estrés y con traumas³. En la clasificación estadística internacional de enfermedades y de problemas relacionados con la salud CIE, es en la versión 10 cuando se adopta el término de trastorno adaptativo, habiéndose definido previamente como reacciones de adaptación, y encontrándose también dentro de los trastornos relacionados con los traumas.

En la tabla 1 se presentan los criterios diagnósticos según el DSM-5³ y la CIE-11⁴.

Características clínicas

Siguiendo lo establecido por las clasificaciones diagnósticas, podemos diferenciar diversos tipos de trastornos adaptativos de acuerdo a los síntomas predominantes.

Nos encontramos ante un trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido cuando las manifestaciones predominantes son síntomas del tipo del estado de ánimo depresivo, llanto o desesperanza. Se diagnosticaría un trastorno adaptativo con ansiedad cuando hay un predominio de los síntomas como nerviosismo, preocupación o inquietud; así como, en el caso de los niños, ante la aparición de miedo a la separación de las figuras principales. Debe considerarse el trastorno adaptativo mixto, con ansiedad y estado de ánimo depresivo cuando las manifestaciones principales son una mezcla de síntomas de depresión y ansiedad.

El trastorno adaptativo con trastorno del comportamiento o con alteración de la conducta se produce cuando la manifestación sintomática predominante es una alteración del comportamiento en la que hay una violación de los derechos

TABLA 1

Criterios diagnósticos de los trastornos de adaptación de acuerdo con las clasificaciones DSM y CIE

Criterios diagnósticos de los trastornos de adaptación (DSM-5)

- Desarrollo de síntomas emocionales o del comportamiento en respuesta a un factor o factores de estrés identificables que se producen en los tres meses siguientes al inicio del factor(es) de estrés
- Estos síntomas o comportamientos son clínicamente significativos, como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes
 - Malestar intenso desproporcionado a la gravedad o intensidad del factor de estrés, teniendo en cuenta el contexto externo y los factores culturales que podrían influir en la gravedad y la presentación de los síntomas
 - Deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento
- La alteración relacionada con el estrés no cumple los criterios para otro trastorno mental y no es simplemente una exacerbación de un trastorno mental preexistente
- Los síntomas no representan el duelo normal
- Una vez que el factor de estrés o sus consecuencias han terminado, los síntomas no se mantienen durante más de otros seis meses

Especificar si es

Agudo: si la alteración dura menos de 6 meses

Persistente (crónico): si la alteración dura 6 meses o más

Criterios diagnósticos de los trastornos de adaptación (CIE-11)

El trastorno de adaptación es una reacción desadaptativa a un estresante psicosocial identificable o múltiples factores de estrés (por ejemplo, divorcio, enfermedad o discapacidad, problemas socioeconómicos, conflictos en el hogar o en el trabajo) que, por lo general, surge en el plazo de un mes desde la presentación del factor estresante. El trastorno se caracteriza por la preocupación por el factor estresante o sus consecuencias, incluida la preocupación excesiva, pensamientos recurrentes y angustiosos sobre el factor estresante, o cavilación constante sobre sus implicaciones, así como por la falta de adaptación al estrés que provoca un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educativa, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no son de especificidad o gravedad suficiente para justificar el diagnóstico de la presencia de otro trastorno mental y del comportamiento y, por lo general, se resuelven dentro de los 6 meses, a menos que el factor estresante persista durante más tiempo

Exclusiones

- Trastorno depresivo recurrente (6A71)
- Trastorno depresivo, episodio único (6A70)
- Trastorno por duelo prolongado (6B42)
- Duelo sin complicaciones (QE62)
- Síndrome de desgaste ocupacional (QD85)
- Reacción al estrés agudo (QE84)
- Trastorno de ansiedad por separación en niños

de los demás o de normas y reglas sociales apropiadas a la edad. En el caso del subtipo con alteración mixta de las emociones y del comportamiento, las manifestaciones predominantes son tanto síntomas emocionales como alteraciones del comportamiento. Por último, en el subtipo no especificado se incluyen las reacciones desadaptativas a estresantes psicosociales, como pueden ser quejas somáticas, aislamiento social, inhibición laboral o académica, que no son clasificables en los subtipos específicos del trastorno adaptativo.

Atendiendo a la evolución de los trastornos adaptativos, estos pueden clasificarse como agudos, cuando su duración es inferior a seis meses, o crónicos cuando superan este límite temporal. El trastorno adaptativo puede persistir de forma indefinida mientras persista el factor estresante que lo originó, pero no puede ser diagnosticado si el estresor ha desaparecido en los últimos seis meses, aunque persista la sintomatología.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial es especialmente importante en el caso de los trastornos de adaptación, ya que es necesario des-

cartar la existencia de un trastorno mental más específico o la agudización de cualquier trastorno crónico previo. Así, el trastorno de adaptación no puede ser diagnosticado si se cumplen criterios para otro trastorno mental.

Especialmente importante será realizar el diagnóstico diferencial con los trastornos depresivos, como el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente o distimia, el trastorno disfórico premenstrual, así como con otros trastornos depresivos especificados o no especificados.

Si aparecen síntomas ansiosos, deberemos valorar la posibilidad de encontrarnos ante un trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, así como aquellos otros trastornos especificados y no especificados, en vez de ante un trastorno de adaptación.

Si nos encontramos ante una persona con un diagnóstico de trastorno de la personalidad, no podríamos considerar el doble diagnóstico de trastorno de adaptación y deberíamos caracterizarlo como una agudización de la patología de base.

Atendiendo al apartado de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, deberemos realizar la diferenciación con el trastorno de estrés postraumático (TEPT), trastorno de estrés agudo y otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado y no especificado.

Por otra parte, aunque la muerte de un ser querido puede ser considerada como un factor estresante, tanto el DSM como la CIE consideran el duelo como un diagnóstico distinto del trastorno adaptativo.

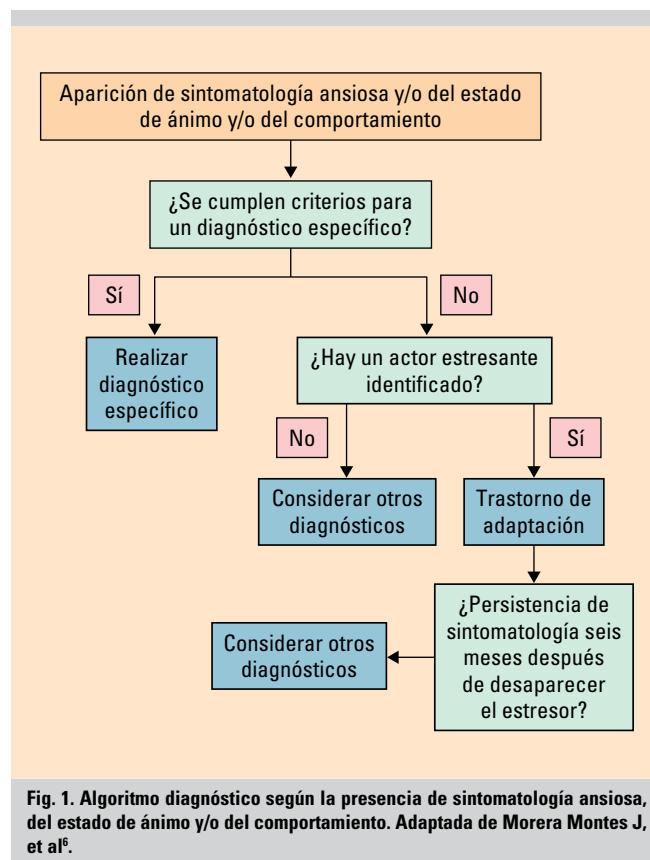
Resulta fundamental también realizar el diagnóstico diferencial con aquellas respuestas ante problemas psicosociales y ambientales que pudieran considerarse como una reacción normal ante dichos eventos estresantes. Tanto el DSM como la CIE indican que la reacción ante el evento estresor debe ser desadaptativa y provocar un deterioro significativo en la vida personal, familiar, social, educativa y laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento del individuo. No contamos a día de hoy con directrices que permitan distinguir cuándo nos encontramos ante una reacción adaptativa normal frente a un estímulo estresante y cuándo debemos considerar que dicha reacción es patológica. Tampoco se especifica claramente qué tipo de acontecimientos podrían considerarse como estresores y, en este sentido, la ausencia de criterios específicos que ayuden a definir los estresores y las reacciones asociadas dificultan enormemente el diagnóstico⁵.

En último lugar, es necesario descartar el origen orgánico en la aparición de la sintomatología, así como la influencia de determinados fármacos o del consumo de sustancias.

En la figura 1 se presenta un esquema que puede resultar de utilidad en la toma de decisiones a la hora de realizar el diagnóstico diferencial de trastorno de adaptación⁶.

Instrumentos de evaluación

Atendiendo a los problemas de definición de este trastorno y al poco interés que ha despertado en la comunidad científica,



hay escasos instrumentos específicos de evaluación y diagnóstico.

Dentro de los instrumentos generales, podemos destacar la entrevista para la evaluación clínica en neuropsiquiatría⁷. Esta entrevista, basada en los criterios de la CIE-10 y el DSM-IV, incluye entre los diagnósticos posibles el trastorno de adaptación una vez descartados otros diagnósticos, aunque no incluye preguntas específicas ni una guía que sirva de ayuda al entrevistador a la hora de realizar este diagnóstico.

Otra entrevista diagnóstica estructurada que podemos emplear es la Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-5⁸.

Entre los instrumentos específicos podemos destacar la *Diagnostic Interview Adjustment Disorder* (DIAD)⁹, entrevista diagnóstica elaborada por Cornelius et al. Existen también instrumentos breves de cribado, como el cuestionario de Guldbrandsen¹⁰, que cuenta con nueve ítems.

Otro instrumento que puede resultar de utilidad en la evaluación de los trastornos de adaptación es el Inventario de Estrés y Pérdida (IEP)¹¹ que evalúa hasta qué punto cualquier tipo de pérdida, como puede ser la de un familiar o amigo, una pérdida de estatus o de la salud puede interferir en la vida del individuo.

En cuanto a la evaluación de los eventos vitales estresantes, existen gran cantidad de instrumentos adaptados para la población española como la Escala de Sucesos Vitales (ESV)¹², las Escalas de Apresiasi del Estrés (EAE)¹³ o el Cuestionario de Sucesos Vitales (CSV)¹⁴, entre otros.

Etiopatogenia

Como hemos planteado anteriormente, a la hora de realizar un diagnóstico de trastorno de adaptación, es necesario que exista un factor estresante identificable implicado en el origen de la sintomatología.

Lazarus y Folkman definen el estrés como el resultado de la interrelación entre la persona y su contexto. Por tanto, el estrés se produciría cuando la persona valora que el acontecimiento estresante supera sus propios recursos de afrontamiento, pudiendo llegar a suponer un peligro para su bienestar personal, con la consiguiente aparición de respuestas emocionales. Ante situaciones estresantes, las personas despliegan unos «esfuerzos cognitivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo» (Lazarus y Folkman, 1986)¹⁵.

Entre los acontecimientos estresantes que se pueden encontrar detrás de un trastorno adaptativo, podemos destacar aquellas situaciones capaces de provocar problemas psicosociales, como pueden ser las situaciones de crisis personal o sociofamiliar, ciertos acontecimientos vitales estresantes, así como las transiciones o cambios en las etapas del ciclo vital.

A modo ilustrativo, en la tabla 2 podemos encontrar la escala de evaluación de reajuste social de Holmes y Rahe¹⁶, donde se enumeran algunos de los acontecimientos vitales más frecuentemente relacionados con la aparición de estrés, así como la valoración cuantitativa del impacto y cambio vital que estos pueden suponer para el individuo que los sufre.

Fabrega y colaboradores (1987)¹⁷ encontraron un mayor número de eventos estresantes en un grupo de pacientes con diagnóstico de trastorno adaptativo en comparación con el grupo control sin enfermedad, así como también, lo que resulta más llamativo, en comparación con un grupo que tenía un diagnóstico de trastorno mental específico.

Evidentemente, más allá del evento estresante como factor etiológico necesario en el desarrollo de trastornos de adaptación, debemos atender a aquellas variables moduladoras del mismo como pueden ser la fuerza del yo, los sistemas de apoyo con los que cuenta el individuo, la experiencia previa ante eventos estresantes, la evaluación cognitiva que hace la persona sobre la situación y sus propios recursos para hacerle frente, el encadenamiento de varios acontecimientos estresantes en un mismo momento temporal o los mecanismos de afrontamiento que puede poner en juego la persona para amortiguar el impacto del estresor¹⁸.

El entorno social en el que vive inmersa la persona también puede constituir tanto un factor protector como un factor de riesgo en el desarrollo del trastorno¹⁹.

Curso de la enfermedad

En un estudio realizado por Andreansen y Hoenk²⁰ se observó que el pronóstico a largo plazo del trastorno de adaptación es bueno en adultos. Sin embargo, en el caso de los adolescentes parece haber cierta tendencia a que el cuadro termine evolucionando a otro trastorno mental. Así, tanto la

TABLA 2

Escala de reajuste psicosocial de Thomas Holmes y Richard Rahe

Suceso vital	Valor
1. Muerte del cónyuge	100
2. Divorcio	73
3. Separación	65
4. Privación de la libertad	63
5. Muerte de un familiar próximo	63
6. Enfermedad o incapacidad graves	53
7. Matrimonio	50
8. Perder el empleo	47
9. Reconciliación de la pareja	45
10. Jubilación	45
11. Enfermedad de un pariente cercano	44
12. Embarazo	40
13. Problemas sexuales	39
14. Nuevo miembro en la familia	39
15. Cambios importantes en el trabajo	39
16. Cambios a nivel económico	37
17. Muerte de un amigo íntimo	37
18. Cambiar de empleo	36
19. Discusiones con la pareja	35
20. Pedir una hipoteca de alto valor	31
21. Hacer efectivo un préstamo	30
22. Cambio de responsabilidades laborales	29
23. Un hijo/a abandona el hogar	29
24. Problemas con la ley	29
25. Logros personales excepcionales	28
26. La pareja comienza o deja de trabajar	26
27. Inicia/termina el ciclo de escolarización	26
28. Cambios en las condiciones de vida	25
29. Cambio en los hábitos personales	24
30. Problemas con el jefe	23
31. Cambio horario o de condiciones de trabajo	20
32. Cambio de residencia	20
33. Cambio a una escuela nueva	20
34. Cambio en frecuencia de las diversiones	19
35. Cambio en las actividades religiosas	19
36. Cambio en las actividades sociales	18
37. Pedir una hipoteca o préstamo menor	17
38. Cambios en los hábitos del sueño	16
39. Cambios en el número de reuniones familiares	15
40. Cambio en los hábitos alimentarios	15
41. Vacaciones	13
42. Navidades	12
43. Infracciones menores de la ley	11

cronicidad de la enfermedad como la presencia de síntomas en los adolescentes eran los principales predictores de una patología mayor al cabo de cinco años. En dicho estudio se comprobó que el 71% de los adultos no cumplía criterios diagnósticos en un seguimiento a cinco años, mientras que el 8% seguía presentando problemas y el 21% había desarrollado una depresión mayor o un problema de alcoholismo. En adolescentes, tras cinco años de seguimiento solo el 44% carecía de un diagnóstico psiquiátrico, mientras que los diagnósticos incluían esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, depresión mayor, trastorno bipolar, abuso de sustancias psicoactivas y trastornos de la personalidad. El número y tipo

de síntomas no resultaron de utilidad para predecir el resultado a largo plazo, pero sí que lo fueron el tiempo de tratamiento y la cronicidad de los síntomas.

En otro estudio se comprobó que, atendiendo a los subtipos clínicos, el trastorno adaptativo con alteración de la conducta, sin importar la edad, parece tener un resultado menos prometedor que los subtipos con síntomas depresivos, ansioso o los subtipos mixtos²¹.

Epidemiología

A pesar de que existen pocos estudios acerca de la prevalencia de los trastornos adaptativos, podríamos afirmar que estamos ante uno de los diagnósticos más comunes dentro de las consultas de salud mental, oscilando entre aproximadamente el 5% y el 20% el porcentaje de individuos estimado en tratamiento ambulatorio de salud mental³. Aunque no hay estudios de prevalencia del trastorno adaptativo en la población general, en el contexto de Atención Primaria e interconsulta psiquiátrica la prevalencia oscila en torno al 21% (Fábrega et al. 1987)¹⁷.

Gómez-Macías et al. (2006)²² encontraron una incidencia del 13,5% al evaluar a los pacientes que acudían a un centro de salud, pudiendo alcanzar una prevalencia de hasta un 35% en personas que padecen condiciones médicas, especialmente si estas son graves, como es el caso de los pacientes con cáncer (Strain et al. 1998)²³.

Se ha señalado que los trastornos adaptativos se relacionan con una elevada incidencia de intentos de suicidio y de suicidios consumados, pudiendo oscilar estos entre un 25% y un 60% de los pacientes diagnosticados²⁴. Sin embargo, los datos parecen indicar que los pacientes con trastornos de adaptación requieren tratamientos menos intensivos que en otro tipo de trastornos, presentan menor riesgo de recaídas y son capaces de recuperar su nivel de funcionamiento previo con relativa facilidad²⁵.

Tratamiento

El tratamiento de los trastornos adaptativos se basa, fundamentalmente, en un alivio de la sintomatología concomitante, así como en ayudar al individuo a obtener un nivel de adaptación comparable al nivel de desempeño que presentaba antes de exponerse al evento estresante. Por tanto, el tratamiento de primera línea será la psicoterapia orientada a la reducción del estrés, al manejo y afrontamiento del acontecimiento estresante y al establecimiento de un sistema de apoyo que funcione como un amortiguador del malestar²⁶.

Las intervenciones farmacológicas deben constituir una segunda línea de tratamiento en el abordaje del trastorno adaptativo, ya que no existen suficientes evidencias acerca de su utilidad. Se ha sugerido el empleo de fármacos ansiolíticos y antidepresivos para el alivio sintomático de los síntomas de ansiedad y depresión, siempre atendiendo a que su uso debe ser limitado en el tiempo y siempre como adyuvante a una intervención psicoterapéutica²⁵.

Duelo

Concepto y consideraciones generales

A pesar de que es ampliamente conocido que la pérdida es una experiencia inherente y natural durante nuestro proceso vital, el fallecimiento de un ser querido es una vivencia difícil que puede conllevar una serie de reacciones emocionales, cognitivas, somáticas y conductuales que varían en términos de duración e intensidad.

El duelo puede definirse como el proceso psicológico que ocurre como consecuencia de una pérdida relevante para la persona. A pesar de que el duelo es una experiencia común, cada duelo es único para la persona que lo padece. En palabras de Bowlby²⁷, el duelo alude a «todos aquellos procesos psicológicos, conscientes e inconscientes que una pérdida pone en marcha».

El término duelo alude a un fenómeno multidimensional y es aplicable a cualquier experiencia de pérdida, pero en la presente actualización nos referimos principalmente al proceso resultante de haber sufrido la pérdida por fallecimiento de un ser querido.

Según la teoría del apego, los seres humanos venimos biológicamente preparados para vincularnos con otras personas, ya que esto resulta indispensable para nuestra supervivencia y nuestro desarrollo físico y emocional²⁷.

El apego podría definirse como el tipo de vínculo resultante de las relaciones establecidas con los cuidadores principales durante los primeros años de vida. Estas relaciones primarias construirán las bases de un estado de bienestar que servirá de sostén para adaptarnos a las diferentes circunstancias estresantes y adversas a lo largo de la vida. Las relaciones de apego tempranas van estableciendo el mapa que nos guiará en el mundo de las relaciones más adelante²⁸.

Una relación de apego seguro permite que podamos desarrollar una imagen positiva y coherente de nosotros mismos, así como una imagen de los otros como personas confiables y disponibles con las que poder establecer relaciones de seguridad. Para ello, durante la infancia es importante que el cuidador haya cumplido la función de ser «refugio seguro» y «base segura»²⁸. La función de refugio tiene que ver con la percepción del otro, y la relación en sí misma, como un lugar seguro al que acudir ante la aparición de un peligro o situación estresante. La función de base alude a la percepción del otro como un sostén desde el que uno se siente con la seguridad suficiente para explorar el mundo y asumir riesgos.

Por todo ello, las relaciones con otros seres humanos suponen el eje en torno al que gira la vida de una persona, tanto en la infancia como a lo largo de su desarrollo y adultez. Por lo tanto, la interrupción de una relación significativa como consecuencia de una pérdida definitiva puede suponer una experiencia de gran intensidad emocional, llegando incluso a la inhibición de la exploración en un mundo en el que el fallecido ya no está.

¿Es el duelo una patología?

La experiencia de duelo es, en principio, un conjunto de reacciones normales con clara función adaptativa y que en la

mayoría de los dolientes no requerirá de intervención por parte de un profesional de la salud mental, salvo en casos en que la persona afectada no cuente con los recursos suficientes para enfrentarse a la pérdida y la realidad posterior. Además, la mayoría de las personas que sufren la pérdida de un ser querido perciben el dolor resultante como una parte necesaria para la aceptación de esta y la posterior adaptación a un mundo en el que la persona querida estará ausente. La sintomatología inicial se considera normal, natural y humana, y además nos enseña el valor de lo perdido²⁹. En este contexto, el dolor adquiere un significado reparador para el doliente.

Integrar una experiencia es el proceso consistente en reorganizar de un modo coherente todos los componentes de esta. Este proceso nos ayuda a colocar nuestras vivencias en un lugar de nuestra biografía, otorgarles un sentido y/o nuevo significado, convirtiéndolas en un aprendizaje. En situaciones con alta carga emotiva, este proceso natural puede verse interrumpido. En la mayoría de las personas que atraviesan un duelo, este proceso se irá dando de forma gradual a medida que el doliente da espacio y voz a las emociones asociadas, junto con el acompañamiento y el apoyo de sus seres queridos. Así el duelo pasará a estar integrado en la historia del individuo y las reacciones iniciales irán disminuyendo de forma gradual. Para que se dé la integración de la experiencia y, por consiguiente, la resolución del duelo, el doliente ha de tomar un papel activo en su recuperación.

Sentimientos como la tristeza, la rabia, el miedo e incluso la culpa, así como conductas de retirada social son algunas de las reacciones más comunes tras la pérdida reciente de un ser querido. A pesar de que muchas de las emociones iniciales son difíciles de experimentar por la persona, su función es claramente adaptativa. En el caso de la rabia, una posible función de esta puede tener que ver con mantener la energía necesaria para superar algunos obstáculos iniciales, dando paso poco a poco a emociones como la tristeza, cuya función se relaciona con la reflexión y la búsqueda de consuelo en otras personas significativas. Es importante mencionar que algunas personas, especialmente durante los primeros momentos tras la pérdida, experimentan un estado de insensibilidad o embotamiento. Esta reacción, cuando se da en fases iniciales, podría considerarse protectora, ya que centrarse en la realidad de la pérdida podría ser demasiado abrumador para el superviviente³⁰.

La presencia de reacciones físicas (alteraciones del sueño, sensación de fatiga, falta de energía, opresión torácica, etc.) también es un aspecto común en las personas que se encuentran atravesando un duelo. Las alucinaciones visuales y auditivas son frecuentes, suelen darse en las semanas posteriores

a la pérdida y, en general, no predicen que el duelo se convierta en complicado³⁰.

Durante la fase de recuperación, el doliente irá de forma progresiva adaptándose a una nueva realidad y rutinas, también conectando de nuevo con emociones agradables que surgen de reanudar actividades que eran gratificantes hasta la pérdida y que, tras esta, habían perdido parte de su poder reforzante. Cabe señalar que el hecho de que cada vez sean más largos los períodos de bienestar no es incompatible con la presencia de momentos caracterizados por punzadas de un intenso dolor, sobre todo coincidiendo con fechas señaladas (aniversario de la pérdida, cumpleaños, navidades, etc.). Aunque la mayoría de los modelos explicativos describen el duelo como un proceso en forma de fases por las que el doliente transitará y tareas que ha de llevar a cabo, el duelo no es un proceso lineal. Durante un período de tiempo la persona puede sentir que se encuentra inmersa en un vaivén de reacciones emocionales, cognitivas y conductuales.

Uno de los modelos más influyentes en la actualidad a la hora de entender el trabajo que ha de llevar a cabo la persona en duelo es el modelo dinámico centrado en tareas de William Worden³⁰. Los modelos centrados en tareas resultan de gran utilidad para profesionales y personas que se encuentran atravesando un proceso de pérdida, ya que se otorga al doliente un papel activo en la elaboración de esta, algo que puede favorecer el sentimiento de agencia que en ocasiones puede verse afectado tras la pérdida. Con anterioridad al surgimiento de modelos centrados en tareas, autores como Bowlby²⁷ y Parkes³¹ contemplaron el proceso de duelo en forma de fases. Dado que ambos enfoques resultan válidos y necesarios para la comprensión de la experiencia de pérdida, en la tabla 3 se resumen las fases habituales del duelo y las tareas asociadas descritas por el modelo centrado en tareas nombrado previamente.

A pesar de que la sintomatología descrita tiene una función adaptativa y protectora, si se cronifica en el tiempo puede dar lugar a cuadros clínicos graves y/o consecuencias altamente disfuncionales en las distintas áreas de la vida de la persona. En aquellos casos en los que la persona mantiene estas reacciones a largo plazo y de forma que interfieren de manera significativa en su funcionamiento cotidiano, estaremos ante la aparición de lo que en la literatura científica se ha denominado «duelo complicado»³².

El estudio y reconocimiento del duelo patológico se remonta al menos varias décadas atrás, cuando Bowlby²⁷ explicó cómo la persona podía quedar en un estado de inhibición y suspensión en la vida si ciertos procesos defensivos se mantenían de manera prolongada ejerciendo una influencia rígida sobre el funcionamiento mental completo de la persona.

TABLA 3
Fases y tareas del duelo

Fases	Reacciones más frecuentes	Tareas
Aturdimiento y <i>shock</i> inicial	Insensibilidad, negación, bloqueo	Aceptar la realidad de la pérdida
Dolor intenso y añoranza	Sintomatología física y emocional más intensa	Elaborar el dolor
Desesperanza y desorganización	Pérdida de sentido y significados. Dificultad para funcionar y asumir nuevos papeles en la vida cotidiana	Adaptarse a un mundo sin el fallecido
Reorganización y recuperación	Creación de nuevas relaciones. Reanudar la vida	Recolocar al fallecido emocionalmente sin renunciar a él

En la conceptualización del duelo complicado, este ha tomado distintas denominaciones en la literatura (patológico, anormal, crónico, prolongado, no resuelto, etc.). Pero más allá de la terminología con la que se haya elegido nombrarlo, en las definiciones actuales se destaca su larga duración y el estado de estancamiento en el que se encuentra la persona, resultando afectadas diversas áreas de su vida. Como veremos a lo largo de la presente actualización, estas son las características sobre las que ponen el acento las principales clasificaciones diagnósticas actuales a la hora de definir el duelo prolongado como entidad diagnóstica. Sin embargo, algunos autores parten de una visión más categorial y definen el duelo patológico como una condición que va más allá de una intensidad o duración mayor que el proceso de duelo natural y ponen el foco sobre las complicaciones que sobrevienen en forma de otros cuadros clínicos. Bajo este prisma, los síntomas del duelo no son patológicos en sí mismos, pero puede que existan otros factores asociados y distintos, por ejemplo, depresión o trauma relacionados con el duelo, que interfieran con el proceso³³.

Mientras que en el duelo de características normales y adaptativas las reacciones irán disminuyendo de forma gradual y dando paso a un recuerdo del fallecido con menos sufrimiento y más dulce, en el caso del duelo complicado estas reacciones se mantendrán o incluso empeorarán con el paso del tiempo. En estos casos, la persona puede permanecer en una fase de negación de la pérdida de forma indeterminada, recurrir a estrategias desadaptativas como forma de manejar ese dolor y/o sentirse continuamente desbordada no mostrando ninguna o escasa mejoría a lo largo del tiempo. No existe acuerdo en la literatura respecto al tiempo estimado para que un duelo pase de ser considerado normal a complicado. La mayor parte de los profesionales reconocen que la duración del duelo suele ser de 1-2 años³⁴, pero esto dependerá, en gran medida, de factores individuales, relacionales y asociados a las circunstancias de la pérdida.

La detección del duelo patológico se lleva a cabo principalmente a través de dos vías: la búsqueda de ayuda terapéutica por este problema o la consulta por algún otro tipo de problema médico o psiquiátrico³⁵. En el segundo caso, es común que la persona haya quedado fijada en el uso de mecanismos centrados en la evitación como forma de afrontamiento, siendo el resultado que los síntomas aparezcan enmascarados y la persona no establezca ninguna o escasa relación con la pérdida.

Factores de riesgo asociados a duelo complicado

Aunque el duelo es un proceso universal para el ser humano, existen factores de diversa índole que influirán en la vivencia y elaboración individual de la pérdida. Las diferencias a la hora de atravesar e integrar esta experiencia se dan entre personas y también en una persona a lo largo de su vida, ya que no todas las pérdidas se elaboran de la misma forma.

Para responder a la pregunta ¿por qué algunas personas encuentran dificultades a la hora de elaborar el duelo?, resulta necesario hacer mención a factores personales, relacionales y circunstanciales.

Personales

Antecedentes personales previos, historia de pérdidas previas no resueltas o con complicaciones asociadas en el pasado y factores de personalidad³⁰. Personas con dificultades para tolerar emociones desagradables y con tendencia al uso de estrategias evitativas en el manejo del malestar tendrán más dificultades para procesar los aspectos dolorosos asociados a la pérdida. El uso de estrategias supresoras de un modo rígido y, en conjunto, con una visión de uno mismo caracterizada por una imagen de autosuficiencia, con frecuencia llevan implícitas ciertas creencias erróneas y dificultades para pedir ayuda en momentos de vulnerabilidad, lo que dificulta la elaboración adecuada del duelo. Personas que han padecido síntomas de trastornos emocionales en el pasado presentan, en muchos casos, una peor evolución del proceso. Asimismo, los problemas de salud implicarían cierto estado de vulnerabilidad, siendo las personas con salud delicada las que tienden a enfermar más durante el duelo³⁵.

Relacionales

El tipo de parentesco y cómo era la relación con la persona fallecida. Las muertes con mayor impacto psicológico son las referidas a las personas más cercanas. Algunos autores hablan de la pérdida de un hijo como la muerte más difícil de todas³⁵. En cuanto al tipo de vínculo establecido con la persona fallecida, relaciones caracterizadas por la ambivalencia, dependencia o en las que quedan asuntos pendientes con el fallecido son aspectos que suelen impedir o dificultar la elaboración de la pérdida³⁰. La culpa suele ser una de las emociones predominantes en estos casos, y no es infrecuente que ocurra un cambio negativo en la visión que el superviviente tenía de sí mismo antes de la pérdida.

Circunstanciales

Factores asociados a las circunstancias de la muerte y los momentos posteriores a la pérdida. Tipos de muerte que dificultan el proceso de duelo son pérdidas inesperadas, múltiples, por homicidio, suicidio y accidente³⁶. En palabras de Alba Pàyas²⁹, el trauma es mucho más intenso cuando la muerte no se ha podido anticipar y no ha existido preparación posible. En la tabla 4 se resumen algunos de los factores que tienden a estar presentes en pérdidas de características traumáticas²⁹.

El momento en el que se inicia el duelo dependerá en gran medida de lo inesperado de la pérdida. En casos de pérdidas anticipadas, como pueden ser procesos en los que ha existido un diagnóstico previo de enfermedad potencialmente grave, el duelo puede iniciarse antes del fallecimiento, ya que la amenaza de pérdida está presente antes de este. En

TABLA 4

Factores de riesgo asociados a pérdidas traumáticas

Sorpresa
Impotencia
Incomprensión
Rapidez
Soledad en el momento
Soledad posterior

casos de pérdidas inesperadas y/o traumáticas, puede ocurrir que la respuesta de *shock* inicial provoque que la respuesta de duelo sea pospuesta. Otro factor influyente en que la respuesta de duelo sea retrasada es la soledad impuesta por la falta de apoyo en los momentos posteriores a la pérdida. Disponer de un entorno seguro, en el que la persona pueda expresar dolor, sintiendo que es recogido y acompañado sin juicio, es condición necesaria para que la persona reconozca el dolor de la pérdida e inicie el procesamiento de la experiencia. En ese sentido, la falta de apoyo social en el momento de la pérdida es un mediador en respuestas de duelo retardadas³⁰.

Sin embargo, los síntomas iniciales e inmediatos a la pérdida no determinan que un duelo se convierta en patológico.

El duelo en las clasificaciones diagnósticas

La cuestión acerca de si la experiencia de duelo prolongado debía ser considerada una patología mental y recogida de esta forma en las clasificaciones diagnósticas ha sido un tema de controversia en las últimas décadas. Por un lado, se ha defendido la necesidad de que el duelo prolongado sea descrito y recogido como diagnóstico en las diferentes clasificaciones. Uno de los posibles objetivos a conseguir con ello podría ser que las personas afectadas pudieran beneficiarse de tratamientos adecuados y mejorar su calidad de vida. Desde este punto de vista, disponer de una categoría diagnóstica que defina el duelo prolongado como una experiencia fuera de los límites de la «normalidad» podría llegar a infundir cierta esperanza en el doliente viendo reconocido su sufrimiento y disponiendo de una ayuda que, entendiendo el duelo según otros planteamientos, podría resultar cuestionable. Por otro lado, existen profesionales que han abogado por lo contrario, entendiendo que la categorización del duelo como trastorno puede dar lugar a la patologización de una experiencia natural con la consecuente medicalización del sufrimiento humano, existiendo la posibilidad de que se acabe desvirtuando el poder reparador de los vínculos en el entorno cercano del doliente.

A pesar de la falta de acuerdo con respecto a la consideración del duelo como un trastorno mental, una cuestión en la que sí existe cierto consenso es que el proceso de duelo puede adquirir un curso diferente al habitual, llegando a generar complicaciones de adaptación en la persona que lo padece.

En DSM-5, edición publicada en 2013, se incluyó el trastorno de duelo complejo persistente en la sección «Afecciones que necesitan más estudio» no considerándose un diagnóstico clínico. En esta misma edición, el duelo no complicado es recogido como un problema adicional en el apartado «Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica», aplicándose cuando el objeto de atención clínica es la reacción normal ante la muerte de un ser querido, siendo la duración y la expresión de esta muy variable entre distintos grupos culturales³.

Recientemente, el trastorno por duelo prolongado ha sido incluido como entidad diagnóstica en las últimas versiones de los sistemas de clasificación más empleados en la actualidad.

TABLA 5

Criterios diagnósticos del trastorno por duelo prolongado (DSM-5-TR)

- A. Muerte de un ser cercano ocurrida al menos 12 meses antes (si son niños, al menos 6 meses)
- B. Desde la muerte, desarrollo persistente de una respuesta de duelo caracterizada por uno o dos de los siguientes síntomas, que se presentan la mayor parte de los días en un grado clínicamente significativo

Los síntomas pueden ocurrir casi todos los días durante al menos un mes

 1. Añoranza intensa por la persona fallecida
 2. Preocupaciones con pensamientos o recuerdos del fallecido (en niños y adolescentes, la preocupación puede centrarse en las circunstancias de la muerte)
- C. Desde la muerte, al menos tres de los siguientes síntomas han estado presentes la mayor parte de los días en un grado clínicamente significativo. Los síntomas pueden ocurrir casi todos los días durante al menos un mes
 1. Alteración de la identidad (por ejemplo, sentimiento como si parte de uno hubiera muerto)
 2. Sentimiento de marcada incredulidad para aceptar la muerte
 3. Evitación de recuerdos o recordatorios que indiquen que la persona ha fallecido (en niños y adolescentes, puede estar caracterizado por esfuerzos para evitar los recordatorios)
 4. Dolor emocional intenso (por ejemplo, ira, amargura, tristeza)
 5. Dificultad para seguir adelante: retomar relaciones y actividades tras la muerte (por ejemplo, dificultades para compartir con amigos, compartir intereses o planificación futura)
 6. Entumecimiento emocional (ausencia o marcada reducción en la intensidad de la emoción, sensación de aturdimiento) como resultado de la muerte
 7. Sentir que la vida no tiene sentido como resultado de la muerte
 8. Sentimiento de intensa soledad como resultado de la muerte
- D. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento
- E. La duración y la intensidad de la reacción de duelo exceden claramente las normas sociales, culturales o religiosas esperadas para la cultura y el contexto del individuo
- F. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, como el trastorno depresivo mayor o el trastorno de estrés posttraumático, y no son atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia (por ejemplo, medicación, alcohol) u otra afección médica

El diagnóstico se puede realizar en función del DSM-5, revisión de texto (DSM-5-TR), o de la Clasificación Internacional de Enfermedades, en su última versión (ICD-11).

En marzo de 2022 fue publicado el DSM-5-TR. Uno de los cambios respecto a versiones predecesoras es la inclusión del trastorno de duelo prolongado como categoría diagnóstica, siendo descartada la denominación de trastorno de duelo complejo persistente propuesta para estudio en DSM-5. En la tabla 5 se presentan los criterios diagnósticos del trastorno por duelo prolongado en el DSM-5-TR^{37,38}.

Los criterios a cumplir para el diagnóstico de trastorno por duelo prolongado son similares en DSM-5-TR y CIE-11. Ambas clasificaciones inciden en el carácter persistente y profundo de la respuesta de duelo, así como en el deterioro en diversas áreas de la vida del individuo, aunque la CIE-11 estima que la respuesta de duelo se extiende por un período de 6 meses o más³⁷.

En versiones anteriores, el DSM establecía un diagnóstico diferencial para la depresión mayor y el duelo. El DSM-IV-TR excluía el diagnóstico de depresión mayor en aquellas personas que estaban inmersas en un proceso de duelo y que, aun cumpliendo criterios para el trastorno depresivo mayor, los síntomas estuviesen presentes desde hace menos de dos meses desde la pérdida. Ya en DSM-5 esta exclusión temporal desaparece, dejándose a criterio del clínico³.

Debido al problema conceptual a la hora de definir el duelo complicado y la reciente inclusión del duelo prolonga-

do como categoría diagnóstica, no existen cifras claras sobre su prevalencia. Algunos datos indican que aproximadamente un 10% de las personas en duelo experimentan síntomas de duelo prolongado a un nivel clínicamente significativo³².

Complicaciones asociadas

Es reconocido que la experiencia de duelo puede ser entendida también como una situación altamente estresante que actúa como factor desencadenante de diferentes cuadros médicos y/o trastornos psicológicos, así como posible factor mediador en el empeoramiento de estos. Aunque resulta fundamental no psicopatologizar la experiencia de duelo en sí misma, los profesionales debemos considerar la necesidad de un abordaje cuando la experiencia de duelo desencadena cuadros clínicos y/o complicaciones severas. Estudios recientes indican que quienes experimentan reacciones de duelo complicadas sufren más depresión, ansiedad, insomnio, dolor precordial e infartos tras la pérdida que los dolientes sin complicaciones, localizándose estos problemas especialmente más de un año después de la pérdida³⁹. La depresión mayor, el TEPT y los trastornos del sueño ocurren con frecuencia y necesitan tratamiento⁴⁰.

Aunque el duelo puede precipitar un episodio depresivo mayor (EDM), especialmente en personas que presentaban una vulnerabilidad previa, conviene no confundir la experiencia de duelo normal con la presencia de dicho cuadro clínico. Resulta fundamental entender las diferencias, ya que la ayuda profesional será diferente en ambas condiciones. Mientras que en la experiencia de duelo adaptativo puede resultar de ayuda un asesoramiento inicial de cara a facilitar la realización de tareas necesarias para la adaptación a la pérdida, en el caso de un EDM será necesario un abordaje psicológico y/o psiquiátrico que puede llegar a incluir tratamiento farmacológico. En la tabla 6 se establecen las diferencias entre las reacciones derivadas de la experiencia de duelo adaptativo y los síntomas de un EDM³.

El duelo puede desencadenar un TEPT, especialmente en casos de muertes inesperadas y violentas. Sin embargo, existen diferencias entre el duelo complicado y TEPT ya que los síntomas compartidos por ambas categorías adquieren un significado diferente en cada una de estas experiencias. En la

TABLA 6
Diagnóstico diferencial entre duelo y depresión mayor

Duelo normal y adaptativo	Depresión mayor
Sentimiento de vacío y pérdida	Estado de ánimo deprimido de forma persistente e incapacidad de esperar felicidad o placer
Dolor intermitente y en forma de oleadas	Estado de ánimo deprimido de forma continuada
Oleadas de dolor asociadas a pensamientos o recuerdos del difunto	Estado de ánimo deprimido no asociado a pensamientos o preocupaciones específicas
La autoestima, por lo general, se muestra conservada	Son frecuentes sentimientos de poca valía y desprecio por uno mismo
El dolor convive con momentos de humor y emociones positivas	Incapacidad para experimentar placer
Ideas de muerte relacionadas, por lo general, con el deseo de reunirse con el fallecido	Ideación suicida relacionada con el deseo de poner fin a la propia vida por sentimientos de inutilidad

TABLA 7
Diagnóstico diferencial entre duelo complicado y trastorno de estrés postraumático

Duelo complicado	Trastorno de estrés postraumático
El síntoma central es la tristeza y el anhelo	El sello distintivo es el miedo
Imágenes intrusivas y preocupaciones sobre la persona fallecida	Pensamientos e imágenes sobre el evento traumático
Evitación de pensamientos y sentimientos dolorosos relacionados con el fallecido	Evitación con el fin de prevenir un peligro

tabla 7 se resumen las diferencias entre ambas condiciones⁴⁰.

La ideación suicida es una de las complicaciones que con frecuencia están asociadas al duelo complicado. Se ha encontrado que el riesgo de tendencias suicidas entre los pacientes con trastorno de duelo prolongado resulta elevado después de controlar otros factores, como la posible psicopatología comórbida, lo que sugiere que la ideación suicida es independiente de otros cuadros clínicos asociados como podrían ser la depresión⁴¹.

Estudios recientes concluyen que existe un mayor riesgo de aparición de una variedad de trastornos del estado de ánimo, ansiedad y consumo de alcohol después de la muerte inesperada de un ser querido a lo largo del curso de la vida⁴².

Abordaje del duelo

El tipo de intervención dependerá, en gran medida, de la magnitud de las reacciones y de las complicaciones presentes en cada caso. Mientras que, en el duelo normal, un tratamiento psicoterapéutico y/o psiquiátrico puede llegar a ser perjudicial, no será así en aquellos casos de duelo prolongado donde la calidad de vida de la persona se ve gravemente alterada a raíz de la pérdida y a lo largo del tiempo.

A pesar de la necesidad compartida por muchos profesionales de normalizar la experiencia de duelo, así como de despatologizar las reacciones iniciales, en algunos casos de duelo puede resultar beneficioso un acompañamiento inicial y puntual que ayude a amortiguar el impacto de las reacciones iniciales, especialmente en casos de pérdidas inesperadas y/o traumáticas. Además, en multitud de ocasiones, los profesionales sanitarios nos encontramos presentes en los momentos que rodean la pérdida. En este contexto, contar con herramientas de asesoramiento y acompañamiento inicial puede resultar útil de cara a que la persona pueda normalizar su experiencia y realizar las tareas necesarias para la elaboración de la pérdida a lo largo del tiempo. Resulta fundamental, en estas primeras etapas, que los profesionales implicados podamos sostener las emociones presentes en un clima libre de juicio, ya que de lo contrario podemos contribuir a que exista un sufrimiento extra al propio dolor de la pérdida.

En la mayoría de las ocasiones, la asunción de un papel activo en la recuperación por parte del doliente, junto con el paso del tiempo y el apoyo de las personas cercanas será suficiente para la resolución exitosa del duelo. Una gran cantidad de personas que han experimentado la experiencia de duelo señalan el poder reparador de los vínculos cercanos y las relaciones establecidas con personas que atravesaban experiencias similares. En ese sentido, puede ser beneficioso

acudir a asociaciones y grupos de ayuda donde la persona puede compartir su experiencia y reflexionar sobre la pérdida sin necesidad de una intervención profesional propiamente dicha.

En casos de duelo complicado, la persona puede beneficiarse de una intervención especializada tanto a nivel individual como grupal. El tratamiento adecuado deberá ser individualizado y enfocado a la resolución de las complicaciones concretas del paciente, siendo el objetivo principal la resolución de conflictos que obstaculizan la resolución de tareas mencionadas en apartados anteriores. La meta principal del tratamiento será que la persona pueda integrar la pérdida de manera que el recuerdo de la persona fallecida no bloquee el funcionamiento en el tiempo presente. De forma previa a la derivación a un profesional de la salud mental especializado en duelo, puede resultar esperanzador para el doliente escuchar decir a su profesional de referencia que existen intervenciones adecuadas que le pueden ayudar con su sufrimiento y complicaciones asociadas.

En muchas personas que experimentan reacciones de duelo complicadas, existe de base un temor a la pérdida de conexión con el fallecido, o incluso caer en el olvido, si avanzan en su proceso. En ese sentido, puede ser de utilidad psicoeducar de forma inicial sobre cuáles son las metas del tratamiento, señalando que el objetivo no es olvidar al ser querido, sino recolocararlo en un lugar que permita seguir viviendo.

La terapia de duelo complicado enfatiza el procesamiento de la pérdida y la restauración de la vida, utilizando una variedad de técnicas que incluyen la terapia cognitiva conductual, la terapia interpersonal y la entrevista motivacional⁴³.

La terapia de duelo irá enfocada al desarrollo y fortalecimiento de estrategias que mantienen a la persona conectada con la vida y el presente, así como con el afrontamiento y exposición de los aspectos más dolorosos relacionados con la pérdida y las consecuencias derivadas. Previo a cualquier tipo de abordaje, será conveniente una evaluación detallada de la problemática individual del paciente, así como la detección de posibles cuadros clínicos comórbidos que puedan estar interfiriendo y sean susceptibles de tratamiento.

La alianza terapéutica se convierte en la herramienta más potente en el abordaje del duelo. Puesto que el duelo es la experiencia resultante de la pérdida de una relación, la recuperación no se puede disociar de esta. Por tanto, el desarrollo de una relación terapéutica sólida, donde el paciente pueda sentirse aceptado de forma incondicional y sienta que puede expresar sus sentimientos y dificultades sin ser juzgado, resultará imprescindible. La forma en la que se establece el vínculo terapéutico es crucial, ya que será el espacio en el que el paciente se irá exponiendo a su mundo interno, pudiendo ser este uno de sus mayores temores.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

1. ● Strain JJ, Diefenbacher A. The adjustment disorders: the conundrums of the diagnoses. *Compr Psychiatry* [Internet]. 2008;49(2): 121-30. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010440X07001423>
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-III (3ª ed). Washington DC; 1980.
3. ●● American Psychiatric Association (APA). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5 (5ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014.
4. Organización Mundial de la Salud (OMS). Clasificación Internacional de Enfermedades, undécima revisión (CIE-11), 2019/2021. Disponible en: <https://icd.who.int/browse11>
5. ● Baumeister H, Kufner K. It is time to adjust the adjustment disorder category. *Curr Opin Psychiatry*. 2009;22(4):409-12. doi: 10.1097/YCO.0b013e32832cae5e.
6. Morera Montes J, Calvo Corbella E. Trastornos adaptativos. En: Vázquez-Barquero JL, eds. *Psiquiatría en Atención Primaria*. 2ª ed. Madrid: Aula Médica; 2007. p. 307-19.
7. Organización Mundial de la Salud. SCAN; Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry, Wing et al., 1990. Segunda versión. OMS, 1994.
8. First MB, Williams JB, Karg RS, Spitzer RL. Structured clinical interview for DSM-5—Research version (SCID-5 for DSM-5, research version; SCID-5-RV). Arlington VA Am Psychiatr Assoc. 2015.
9. Cornelius LR, Brouwer S, de Boer MR, Groothoff JW, van der Klink JJJL. Development and validation of the Diagnostic Interview Adjustment Disorder (DIAD). *Int J Methods Psychiatr Res*. 2014;23(2):192-207. doi: 10.1002/mpr.1418.
10. Gulbrandsen P, Hjortdahl P, Fugelli P. General practitioners' knowledge of their patients' psychosocial problems: multipractice questionnaire survey. *BMJ*. 1997;314(7086):1014-8. doi: 10.1136/bmj.314.7086.1014.
11. Quero S, Mor S, Molés M. Exploring the assessment of adjustment disorders: differences between a general and a clinical sample. *Psicothema* [Internet]. 2019;(31.1):17-23. Disponible en: <https://doi.org/10.7334/psicothema2018.159>
12. Blasco-Fontecilla H, Delgado-Gómez D, Legido-Gil T, de León J, Pérez-Rodríguez MM, Baca-García E. Can the Holmes-Rahe Social Readjustment Rating Scale (SRRS) be used as a suicide risk scale? An exploratory study. *Arch Suicide Res*. 2012;16(1):13-28. doi: 10.1080/13811118.2012.640616.
13. Fernández Seara JL, Mielgo Robles M. Escalas de apreciación del estrés. Madrid: TEA Ediciones SA; 1992.
14. Sandín B, Chorot P. Cuestionario de sucesos vitales (CSV): Estructura factorial, características psicométricas y datos normativos. *RPPC* [Internet]. 2017;22(2):95-115. Disponible en: <https://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/19729>.
15. Lazarus RS, Folkman S. Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Ed. Martínez-Roca; 1986.
16. Holmes TH, Rahe RH. The Social Readjustment Rating Scale. *J Psychosom Res*. 1967;11(2):213-8. doi: 10.1016/0022-3999(67)90010-4.
17. Fabrega H Jr, Mezzich JE, Mezzich AC. Adjustment disorder as a marginal or transitional illness category in DSM-III. *Arch Gen Psychiatry*. 1987;44(6):567-72. doi: 10.1001/archpsyc.1987.01800180087013.
18. Cohen F. Stress and bodily illness. *Psychiatr Clin North Am* [Internet]. 1981;4(2):269-86. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193953X18309225>

19. Andreasen NC. Adjustment disorders in adolescents and adults. *Arch Gen Psychiatry* [Internet]. 1980;37(10):1166-70. Disponible en: <https://doi.org/10.1001/archpsyc.1980.01780230084012>
20. ● Andreasen NC, Hoenk PR. The predictive value of adjustment disorders: a follow-up study. *Am J Psychiatry*. 1982;139(5):584-90. doi: 10.1176/ajp.139.5.584.
21. Thomas A, Chess S. Genesis and evolution of behavioral disorders: from infancy to early adult life. *Am J Psychiatry*. 1984;141(1):1-9. doi: 10.1176/ajp.141.1.1.
22. Gómez Macías V, De Cós Milas A, García Blanco C, García Sánchez F, Ballesteros García M, Ávalos J. Trastornos adaptativos: factores estresantes en el momento actual. *Interpsiquis* [Internet]. 2006; VII. Disponible en: <http://psiqui.com/1-3197>
23. Strain JJ, Smith GC, Hammer JS, McKenzie DP, Blumenfeld M, Muskin P, et al. Adjustment disorder: a multisite study of its utilization and interventions in the consultation-liaison psychiatry setting. *Gen Hosp Psychiatry*. 1998;20(3):139-49. doi: 10.1016/s0163-8343(98)00020-6.
24. Casey P, Bailey S. Adjustment disorders: the state of the art. *World Psychiatry*. 2011;10(1):11-8. doi: 10.1002/j.2051-5545.2011.tb00003.x.
25. Jones R, Yates WR, Williams S, Zhou M, Hardman L. Outcome for adjustment disorder with depressed mood: comparison with other mood disorders. *J Affect Disord*. 1999;55(1):55-61.
26. ●● Zapata-Ospina JP, Sierra-Muñoz JS, Cardeno-Castro CA. Diagnóstico y tratamiento del trastorno de adaptación en Atención Primaria. *Semergen*. 2021;47(3):197-206. doi: 10.1016/j.semerg.2020.09.010.
27. ●● Bowlby J. La pérdida afectiva. Tristeza y depresión. Barcelona: Paidós; 1993.
28. Pitillas C, Berástegui A. Primera alianza: Fortalecer y reparar los vínculos tempranos. Barcelona: Editorial GEDISA; 2018.
29. ●● Payàs A. El mensaje de las lágrimas. Una guía para superar la pérdida de un ser querido. 11.ª ed. Barcelona: Paidós; 2014.
30. ●● Worden JW. El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia. 4.ª ed. Barcelona: Paidós; 2013.
31. Parkes CM. Bereavement: studies of grief in adult life. London: Penguin Books; 1996.
32. ●● Lundorff M, Holmgren H, Zachariae R, Farver-Vestergaard I, O'Connor M. Prevalence of prolonged grief disorder in adult bereavement: A systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord* [Internet]. 2017;212:138-49. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032716318651>
33. ● Maciejewski PK, Maercker A, Boelen PA, Prigerson HG. "Prolonged grief disorder" and "persistent complex bereavement disorder", but not "complicated grief", are one and the same diagnostic entity: an analysis of data from the Yale Bereavement Study. *World Psychiatry* [Internet]. 2016;15(3):266-75. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/wps.20348>
34. Vedia Domingo V. Duelo patológico. Factores de riesgo y protección. *Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia*. 2016;6(2).
35. ●● Echeburúa Odriozola E, Herrán Boix A. ¿Cuándo el duelo es patológico y cómo hay que tratarlo? *Análisis Modif Conducta* [Internet]. 2007;33(147):31-50. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2388069>
36. ● Barreto Martín MP, Soler Sáiz MC. Apoyo psicológico en el sufrimiento causado por las pérdidas: el duelo. *Monogr Humanit* [Internet]. 2004;(2):139-50. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6669546>
37. ● Levy Yeyati E. Trastorno por duelo prolongado: un nuevo diagnóstico en el DSM-5TR. *Vertex Rev Argent Psiquiatr* [Internet]. 2022;33(156):51-5. Disponible en: <https://revistavertex.com.ar/ojs/index.php/vertex/article/view/179>
38. ● Prigerson HG, Boelen PA, Xu J, Smith KV, Maciejewski PK. Validation of the new DSM-5-TR criteria for prolonged grief disorder and the PG-13-Revised (PG-13-R) scale. *World Psychiatry* [Internet]. 2021;20(1):96-106. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7801836/>
39. Rodríguez-Álvaro M. Impacto del duelo complicado. Una lectura a través del lenguaje del cuidado. 2019;13(3). Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2019000300008&lng=es&nrm=iso&tlng=pt
40. ●● Shear MK, Simon N, Wall M, Zisook S, Neimeyer R, Duan N, et al. Complicated grief and related bereavement issues for DSM-5. *Depress Anxiety*. 2011;28(2):103-17. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3075805/>
41. ● Latham AE, Prigerson HG. Suicidality and bereavement: Complicated grief as psychiatric disorder presenting greatest risk for suicidality. *Suicide Life Threat Behav* [Internet]. 2004;34(4):350-62. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1459278/>
42. ● Keyes KM, Pratt C, Galea S, McLaughlin KA, Koenen KC, Shear MK. The burden of loss: Unexpected death of a loved one and psychiatric disorders across the life course in a national study. *Am J Psychiatry* [Internet]. 2014;171(8):864-71. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4119479/>
43. Simon NM. Treating complicated grief. *JAMA* [Internet]. 2013;310(4):416-23. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4530627/>